Mise au point sur le traitement antibiotique des gastro-entérites à *Shigella sonnei*

Mise au point AFSSAPS 2004

Introduction

- En France, *Shigella sonnei* est l'espèce prédominante parmi les shigelles, responsable de gastroentérites.
- La résistance de *S sonnei* aux aminopénicillines et au cotrimoxazole ne permet plus de recommander ces traitements en première intention

Diagnostic d'une gastro entérite à *S. sonnei*

- Incubation brève: quelques heures à quelques jours (48h)
- Evolution spontanée résolutive le plus souvent en 3-4 jours
- Il existe des cas sévères nécessitant une hospitalisation
- Seule la coproculture permet l'identification de la bactérie

Indications de la coproculture

- Diarrhée glairo-sanglante (syndrome dysentérique) quel que soit le contexte de survenue
- Diarrhée banale dans une collectivité d'enfants touchés
- Sujet symptomatique ayant eu un contact avec une personne chez qui le diagnostic bactériologique de *Shigella sonnei a été confirmé.*
- Retour dans une collectivité.
  - Pour les enfants: retour dans la collectivité permise si 2 coprocultures négatives à 24 h d'intervalle, 48h après l'arrêt du traitement

Traitement

- Pourquoi traiter ?
  - diminuer le portage et la contagion
  - réduire la durée des symptômes
  - réduire le risque de complications
- Qui et Quand traiter:
  - Cas isolé: si isolement de *S sonnei* dans une coproculture
  - Cas groupés symptomatiques autour d'un cas confirmé bactériologiquement

Traitement antibiotique

Enfants

- **Forme peu sévère**

Azithromycine (PO) : 20 mg/kg/jour en une prise unique journalière sans dépasser la posologie adulte (500 mg/jour), pendant 3 jours.

- **Forme sévère ou intolérance digestive**

Ceftriaxone (IM) : 50 mg/kg/jour en une seule injection quotidienne, sans dépasser la posologie adulte (2 g/jour), pendant 3 jours.

- **Echec des traitements précédents**

Adultes

- **Première intention**

- Ciprofloxacine (PO) : 500 à 750 mg deux fois par jour, pendant 3 jours ;

- ou Ofloxacine (voie orale) : 200 mg deux fois par jour, pendant 3 jours.

- **En cas d'intolérance digestive ou échec au traitement de première intention par fluoroquinolone**

Ceftriaxone (IM: 1 à 2 g/jour en une seule injection quotidienne, pendant 3 jours.

Traitement non antibiotique

- Hydratation +++
- Pas de ralentisseurs du transit
- Lavage des mains +++ avant les repas et après passage aux toilettes

Post Recommendations

- Des souches de S. sonneï résistantes à l'Azithromycine ont été décrite dans différentes régions du monde
- Leur dépistage nécessite des techniques particulières (E-test)